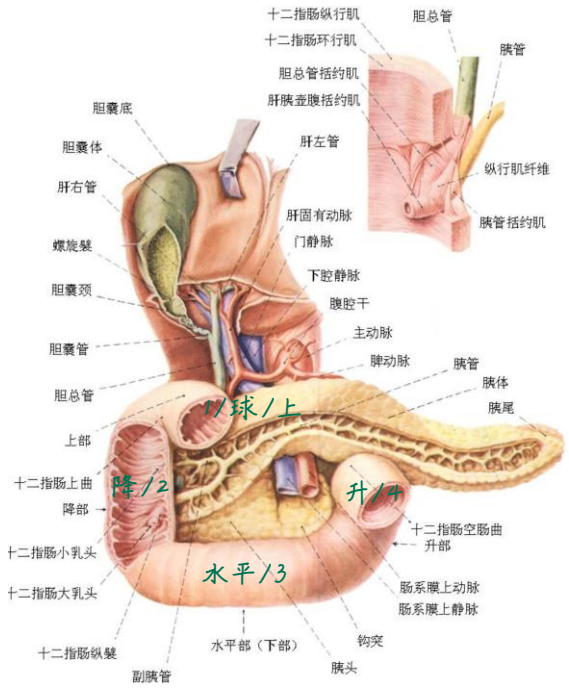
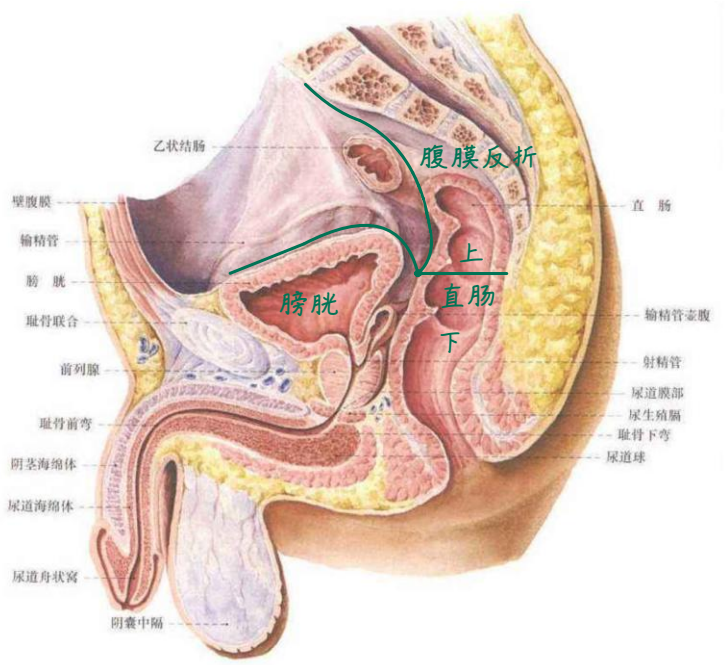
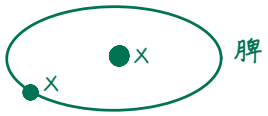




三、腹部损伤的可能可能最可能和治疗

	早期休克	腹膜炎	看主诉、看部位　　天天师兄提示
脾	多有 实质脏器出血量大	早而轻 不是腹膜外位器官	左上腹外伤、左膈肌抬高关注原发部位  治疗： ①脾修补或切除、同时抗休克　免疫器官，6岁内尽量不切 ②<6 岁：若切脾后可自体脾片移植（避免肺炎链球菌感染为主的 OPSI） ③可行回收式自体输血（回输浓缩红）不存在免疫反应且脾脏出来的血是干净的 ④延迟性脾破裂的预防：绝对卧床>1 周 一旦遭受轻微外力，出血量就立马↑
肝	多有 双重血供 	早而重 胆汁刺激	右上腹外伤、右膈肌抬高　未必是消化道的损伤，也可能是肝脏的损伤，因为血液可以经过胆道进入十二指肠，引起呕血和黑便 血液经胆道进入十二指肠→呕血或黑便 累及肝静脉主干或下腔静脉→空气栓塞 中央型（胆管粗）肝破裂的血肿→继发肝脓肿　越靠近中央，胆管越粗，细菌容易聚集  治疗：肝脏破裂如果回收血液会混合胆汁（脏的） ①肝修补、同时抗休克　肝蒂内有肝A、门V、胆管 ②大量活动性出血：阻断肝十二指肠韧带止血/门管三联入肝血流阻断法，每次阻断<20-30、肝硬化<15 分钟 避免出现坏死
空回肠	多无 空腔脏器失血量少	早而重	中下腹外伤、脐周为著（脐周痛警惕小肠、阑尾疾病）、呕血或黑便，可有肝浊音界缩小消失 肝周围是负压，吸引大量气体积聚影响叩诊 治疗：肠修补或切除吻合 空回肠非常干净，可以一期切除吻合
十二指肠 2/3 部 占地面积大	多无	晚而重 腹膜外位器官	呕血或黑便，可有睾丸痛、阴茎异常勃起　肠道渗出物刺激腹膜后睾丸神经和伴随精索动脉的交感N　十二烂，鸡难安 疼痛局限在腰背部或上腹偏右，腹部体征相对轻微、但全身情况进行性恶化 症征不符 腰大肌轮廓模糊、腹膜后积气呈花斑样、腹膜后/右肾间隙/肠系膜根部气泡 十二指肠2/3部偏右　都在腹膜后 若气体到达盆腔腹膜后间隙时直肠指检可在骶前扪及捻发音

VS 消化性溃疡：十二指肠球部最早承受胃酸的负荷
球部不在腹膜后，气体跑出来积在肝脏周围，肝浊音界消失是最有价值的体征